Клинические рекомендации

Доброкачественные образования головы и шеи

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**D10.0** — Губы **D10.1** — Языка **D10.2** — Дна полости рта **D10.3** — Других и неуточненных частей рта **D11.0** — Околоушной слюнной железы **D11.7** — Других больших слюнных желез **D11.9** — Большой слюнной железы неуточненное **D13.0** — Пищевода **D14.0** — Среднего уха, полости носа и придаточных пазух **D16.0** — Лопатки и длинных костей верхней конечности **D17.0** — Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки головы, лица и шеи **D18.0** — Гемангиома любой локализации **D18.1** — Лимфангиома любой локализации **D19.0** — Мезотелиальной ткани плевры **D21.0** — Соединительной и других мягких тканей головы, лица и шеи **D22.0** — Меланоформный невус губы **D23.0** — Кожи губы **D23.1** — Кожи века, включая спайку век **D23.2** — Кожи уха и наружного слухового прохода **D23.3** — Кожи других и неуточненных частей лица **D23.4** — Кожи волосистой части головы и шеи **D36.0** — Лимфатических узлов **D36.7** — Других уточненных локализаций **D36.9** — Доброкачественное новообразование неуточненной локализации
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 18.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/842_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения **3**

2. Клиническая картина и классификация **3**

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 5
3.1 Критерии диагноза 5
3.2 Жалобы и анамнез 5
3.3 Физикальное обследование 5
3.4 Лабораторные исследования 5
3.5 УЗИ слюнных желёз и лимфатических узлов 6
3.6 Дуплексное сканирование сосудов челюстно-лицевой области 6
3.7 МРТ или КТ мягких тканей с контрастированием 6
3.8 Пункция мягких тканей под контролем УЗИ 6
3.9 Патологоанатомическое исследование 6
3.10 КТ-фистулография 6
4. Лечение 7
4.1 Хирургическое лечение 7
4.2 Сосудистые новообразования 7
4.3 Консервативное лечение 8
4.4 Медицинская реабилитация 8
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 8
6. Источник и актуальность 9
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 9

1. Основные положения

- Доброкачественная опухоль: новообразование с медленным ростом, без метастазирования и без рецидива после полного удаления; клетки высокодифференцированы и нечувствительны к лучевому воздействию.
- **Диагноз устанавливают по совокупности**
  1. образование головы или шеи, выявленное при физикальном и инструментальном обследовании;
  2. исключение другой патологии со схожей клинической картиной;
  3. заключение гистологического исследования.
- **Основа обследования**
  1. УЗИ слюнных желёз и (или) лимфатических узлов при любом объёмном образовании головы и шеи;
  2. МРТ или КТ мягких тканей с контрастированием, если образование занимает несколько анатомических областей или имеет полость;
  3. пункция под контролем УЗИ для дифференциальной диагностики;
  4. морфологическое исследование любого образования.
- При подозрении на сосудистое образование выполняют дуплексное сканирование сосудов, а от предоперационной биопсии отказываются из-за риска кровотечения.
- Основной метод лечения хирургический. Консервативное лечение допустимо только при воспалении отдельных форм, чтобы затем оперировать в плановом порядке; при сосудистых образованиях возможны склеротерапия и другие нехирургические методы.
- Неотложная госпитализация требуется при присоединении воспаления (кистозные образования) и при обильном, профузном, продолжающемся кровотечении (сосудистые опухоли).

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Опухолью называют избыточную ненормальную массу ткани, которая возникает в результате чрезмерного неконтролируемого клеточного роста, сохраняющегося даже после прекращения влияния вызвавших его факторов (R. Willis).

1. **эксцизионная биопсия** — забор для исследования патологического образования целиком
2. **инцизионная биопсия** — забор части образования либо диффузно изменённого органа
3. **органоспецифические опухоли** — характерны для определённого органа и его специфических структур
4. **органонеспецифические опухоли** — не имеют типичной органной локализации

2.2 Этиология и эпидемиология

Патогенез доброкачественных опухолей основан на нарушении механизмов контроля деления и роста клеток, а также механизмов апоптоза. К предрасполагающим факторам относят механическую или термическую травму, вирусы, эндокринные нарушения. Опухолеподобные образования и пороки развития формируются вследствие нарушения развития I и II жаберных дуг и щелей, глоточных карманов или эмбриогенеза сосудистой и лимфатической системы.

Новообразования и опухолеподобные процессы полости рта и челюстно-лицевой области составляют около 20–25% опухолевых заболеваний. Среди доброкачественных опухолей слизистой оболочки полости рта чаще всего встречается папиллома (41,3%), обычно на языке и щеке. Врождённые кисты и свищи составляют около 5% новообразований лица и челюстей; аномалии жаберных щелей встречаются чаще тиреоглоссальных (61 и 39%).

2.3 Классификация

Виды доброкачественных новообразований

1. истинные опухоли;
2. опухолеподобные образования;
3. кисты.

Классификация ВОЗ (2017): кисты и кистоподобные поражения

1. бранхиогенные кисты;
2. киста щитовидного протока;
3. ранула;
4. дермоидные и тератоидные кисты.

Доброкачественные опухоли ЛОР-локализаций по ВОЗ

1. **полость носа, пазухи и основание черепа** — папилломы пазух различного типа, гамартома
2. **носоглотка** — волосатый полип, эктопическая аденома гипофиза, краниофарингиома, ангиофиброма носоглотки, хордома
3. **гортаноглотка, гортань, трахея и парафарингеальное пространство** — папилломы, плоскоклеточная папиллома, кондилома, мультифокальная гиперплазия эпителия, веррукозная лейкоплакия
4. **слюнные железы** — плеоморфная аденома, эпителиоидная гемангиоэндотелиома

Внеорганные опухоли шеи по Г. В. Фалилееву (1970)

1. **нейроэктодермального происхождения** — невринома (неврилеммома), нейрофиброма, ганглионеврома, менингиома, хемодектома каротидная и блуждающего нерва
2. **из производных мезенхимы** — фиброма, десмоид, липома, синовиома, гемангиома, лимфангиома, миома, лейомиома, рабдомиома
3. **дисэмбриональные** — срединная киста шеи, боковая киста шеи, хордома, тимома, тератома

Международная морфологическая классификация

1. **органоспецифические одонтогенные** — амелобластома, одонтома, одонтогенная фиброма, эпулис, цементома, остеобластокластома
2. **органоспецифические опухоли слюнных желёз** — аденома, аденолимфома, смешанная опухоль, киста, мукоэпидермальная опухоль, ангиома, лимфангиома, липома, невринома, нейрофиброматоз
3. **органоспецифические опухоли слизистой оболочки полости рта** — папиллома, фиброма, фиброматоз, миксома, гемангиома, лимфангиома, липома, нейрофиброма
4. **органонеспецифические остеогенные** — остеома, хондрома, оссифицирующая фиброма
5. **органонеспецифические неостеогенные** — гемангиома, гемангиоэндотелиома, хондрома, миксома, нейрофиброма, нейрофиброматоз

2.4 Клиническая картина

Жалобы зависят от вида, локализации и размеров образования. При небольших размерах заболевание долго протекает бессимптомно; при поверхностном расположении пациента беспокоят эстетический дефект, асимметрия лица или само образование.

При увеличении образования или определённой локализации

1. чувство инородного тела;
2. дисфагия, затруднённое глотание;
3. ограничение движений языка или шеи;
4. затруднённое открывание рта.

Как правило, жалобы носят местный характер, общее состояние не страдает. При воспалении кист и кистоподобных образований возникают боль, повышение температуры тела, лихорадка. При отдельных видах образований возможно периодическое кровотечение.

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз доброкачественного образования головы и шеи

1. наличие образования головы или шеи по данным физикального и инструментального обследования, предпринятого после анализа жалоб;
2. исключение другой патологии со схожей клинической картиной;
3. заключение гистологического исследования.

3.2 Жалобы и анамнез

Что уточняют при сборе анамнеза

1. начало заболевания, появление первых симптомов и сроки увеличения образования;
2. боль в области образования и нарушение функции;
3. этиологические факторы, которые можно устранить, чтобы снизить риск рецидива.

Быстрое развитие заболевания может указывать на озлокачествление образования. При переходе воспаления на окружающие ткани появляются общие симптомы, которые затрудняют диагностику и меняют алгоритм лечения.

3.3 Физикальное обследование

Помимо общего осмотра, осматривают само образование и окружающие ткани; осмотр проводят в стоматологическом кресле.

Признаки, которые оценивают

1. размер, форма, чёткость краёв, цвет;
2. спаянность с окружающими тканями, плотность, болезненность при пальпации;
3. инфильтрация подлежащих тканей;
4. расположение относительно сосудов и нервов.

Функции, которые оценивают

1. глотание и речь;
2. движения глазного яблока, мимика;
3. слух;
4. повороты головы и открывание рта.

Нарушение функции бывает патогномоничным: так, срединная киста шеи смещается по средней линии при глотании. Нарушения функций могут осложнить анестезиологическое пособие и требуют привлечения специалистов смежных дисциплин.

3.4 Лабораторные исследования

Перед началом лечения

1. общий (клинический) анализ крови развёрнутый;
2. биохимический общетерапевтический анализ крови, в том числе билирубин, АЛТ и АСТ;
3. коагулограмма с протромбиновым временем, МНО, АЧТВ и фибриногеном;
4. общий (клинический) анализ мочи.

3.5 УЗИ слюнных желёз и лимфатических узлов

Показания

1. любое объёмное образование головы и шеи;
2. оценка регионарных лимфатических узлов.

Диагностические признаки

1. послойная дифференцировка мягких тканей;
2. эхоструктура образования;
3. характер и тип кровотока.

Эффективность УЗИ в выявлении образований шеи составляет 70–90%; картина кистозных образований зависит от нозологической формы.

3.6 Дуплексное сканирование сосудов челюстно-лицевой области

При сосудистых опухолях дуплексное сканирование определяет объём и локализацию образования и его возможный сосудистый компонент.

3.7 МРТ или КТ мягких тканей с контрастированием

Показания

1. образование занимает несколько анатомических областей;
2. наличие полости;
3. уточнение соотношения с окружающими тканями и сосудисто-нервным пучком.

Исследование выполняют **до тонкоигольной аспирационной биопсии**, чтобы пункция не изменила картину образования. По гомогенности, структуре и контурам опухоли при МРТ доброкачественный и злокачественный рост удаётся различить в 90% случаев.

При артериовенозных, капиллярных и венозных мальформациях значительного размера целесообразна КТ-ангиография. Сочетание МРТ и МР-ангиографии различает низкоскоростные и высокоскоростные сосудистые мальформации, а при обширных поражениях исключает или подтверждает вовлечение внутричерепных структур.

3.8 Пункция мягких тканей под контролем УЗИ

Пункцию мягких тканей под контролем УЗИ и пункцию гнойного очага выполняют при образованиях с кодами D10.3, D11, D17.0, D36 для дифференциальной диагностики и выбора методики операции.

Успешны около 80% исследований. Цитологическое заключение об отсутствии опухоли нельзя считать окончательным, так как материал при тонкоигольной биопсии бывает скудным; заключение о наличии опухоли окончательно всегда.

3.9 Патологоанатомическое исследование

Биопсийный (операционный) материал опухолей и опухолеподобных образований мягких тканей исследуют **при малом размере — во время операции**, **при значительном — до операции**. Исследование включает макроскопическое изучение и микроскопию с окрашиванием, в том числе гистохимическими методами.

При подозрении на сосудистое образование от предоперационной биопсии отказываются из-за риска кровотечения.

3.10 КТ-фистулография

При боковых, околоушных и срединных свищах при наличии технической возможности выполняют КТ-фистулографию: она определяет локализацию, длину и ход свищевого канала.

4. Лечение

4.1 Хирургическое лечение

Оценка до лечения (челюстно-лицевой хирург)

1. размер образования и его отношение к окружающим органам;
2. результаты биопсии и визуализации (КТ, МРТ) для оценки распространения;
3. текущий функциональный статус и возможность хирургического лечения.

Вид вмешательства при новообразованиях мягких тканей с кодами D10, D11, D17.0 выбирают тщательно, чтобы снизить риск рецидива. Анестезиологическое пособие подбирают с учётом размеров и локализации образования и его соотношения с органами.

С учётом эстетических запросов пациента опухоли мягких тканей головы и шеи удаляют с использованием видеоэндоскопических технологий: в исследовании (n=65) малоинвазивные эндоскопически ассоциированные вмешательства значительно улучшили эстетические и функциональные результаты в эстетически ценных областях.

Для восстановления эстетики и социализации пациента выполняют резекцию черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой.

Реконструктивно-восстановительные операции по оперативно-техническим приёмам

1. **I группа** — местно-пластические операции тканями, прилежащими к дефекту
2. **II группа** — пластика лоскутами на питающих ножках при обширных и объёмных дефектах
3. **III группа** — аутотрансплантация свободного лоскута с формированием сосудистых анастомозов при сложных обширных дефектах
4. **IV группа** — дистракционный остеогенез при дефектах и недоразвитии костей лицевого черепа
5. **V группа** — лицевое эндопротезирование имплантатами
6. **VI группа** — эктопротезирование: оральные и экстраоральные протезы, протезы уха и носа

4.2 Сосудистые новообразования

Методику удаления сосудистого новообразования выбирают по размеру и локализации, чтобы исключить рецидив. Удаление является основным радикальным методом, особенно при ангиомах небольшого размера: иссечение со сближением краёв раны редко даёт рецидив.

При увеличении размеров образования

1. перевязка приводящих и отводящих сосудов;
2. удаление с пластикой дефекта;
3. при значительном прорастании — реконструктивно-пластические операции: свободный лоскут с сосудистыми анастомозами, резекция лицевых костей, замещение дефекта костным аллотрансплантатом.

Нехирургические методы (только при сосудистых образованиях)

1. склерозирующая терапия;
2. криодеструкция;
3. лазерная терапия;
4. электрохимический лизис;
5. эндоваскулярная терапия.

Частота положительных результатов достигала 84,2% при хирургическом лечении, 81,8% при эндоваскулярной терапии и 96,9% при комбинированном лечении: мультидисциплинарный подход эффективнее.

При низкоскоростных сосудистых опухолях проводят склеротерапию, чтобы по возможности избежать операции.

Препараты

1. #этанол 70%;
2. лауромакрогол 400;
3. натрия тетрадецилсульфат.

Склерозант вводят транскутанно в просвет сосуда, контролируя положение кончика иглы флюороскопией с одновременным введением водорастворимого низкоосмолярного рентгеноконтрастного средства. Повреждение эндотелия ведёт к облитерации сосудов и снижению кровотока в образовании.

4.3 Консервативное лечение

Консервативное лечение рассматривают только при воспалении отдельных форм образований (рубрики D10.2–D10.3, D11 и D23.3–D23.4), чтобы затем оперировать в плановом порядке. Оно состоит из стандартной противовоспалительной и симптоматической терапии.

4.4 Медицинская реабилитация

Всем пациентам после хирургического лечения проводят многоэтапную реабилитацию для полного социального и физического восстановления.

Чем обусловлена необходимость реабилитации

1. операционная травма мягких тканей головы и шеи;
2. риск гнойно-септических осложнений и послеоперационных кровотечений;
3. болевой синдром;
4. нарушения глотания, мимики, открывания рта, движений языка и речи.

1-й этап: ранняя реабилитация в стационаре

1. контроль гемостаза и раневого процесса;
2. купирование послеоперационного болевого синдрома, противоотёчная терапия;
3. ежедневная санация ран растворами антисептиков;
4. консультация медицинского психолога.

2-й этап: с 15-х по 45-е сутки после операции

1. физиотерапия после получения гистологического ответа — для восстановления функции и улучшения вида рубца;
2. лечебная физкультура для восстановления функционального статуса.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Всем пациентам с подозрением на доброкачественное образование головы и шеи необходимы ранняя диагностика и лечение для снижения риска малигнизации.

В информации для пациента указано диспансерное наблюдение **раз в 6 месяцев** **в течение 1 года** с проведением УЗИ.

1. **неотложная госпитализация** — присоединение воспаления (кистозные образования), обильное, профузное и продолжающееся кровотечение (сосудистые опухоли)
2. **плановая госпитализация** — образование без воспаления окружающих тканей

Диагностику в плановой ситуации проводят амбулаторно. Операции выполняют в специализированных отделениях, где возможны малоинвазивные вмешательства; некоторые вмешательства допустимы амбулаторно или в дневном стационаре.

Критерии выписки после неотложной госпитализации

1. уменьшение местных проявлений воспаления;
2. болевой синдром купируется препаратами в амбулаторных условиях;
3. нет признаков кровотечения, постгеморрагическую анемию можно корригировать амбулаторно.

Критерии выписки после плановой операции

1. неосложнённое течение раннего послеоперационного периода;
2. нет гнойно-септических осложнений раневого процесса;
3. болевой синдром контролируется пероральными препаратами;
4. пациент может продолжить лечение амбулаторно под наблюдением врача.

Факторы, ухудшающие исход

1. инфекционные осложнения;
2. нарушение функциональных и эстетических качеств;
3. несоблюдение послеоперационного режима и рекомендаций.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Доброкачественные образования головы и шеи»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 18.12.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	842_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Диспансерное наблюдение раз в 6 месяцев в течение года с УЗИ указано только в информации для пациента (приложение В); в разделе 5 «Профилактика и диспансерное наблюдение» сроки наблюдения не приводятся.
- Первый критерий качества — «Выполнено дуплексное сканирование сосудов челюстно-лицевой области» — сформулирован для всех пациентов, тогда как в разделе 2.4 исследование рекомендовано только при сосудистых опухолях.